



Résumé : 43 recommandations pour développer la chirurgie proctologique ambulatoire avec les mêmes conditions de qualité et sécurité qu'en hospitalisation traditionnelle. Volontairement, ce document ne définit pas de liste d'actes éligibles : « ce n'est pas l'acte qui est ambulatoire mais le trio acte / patient / organisation de soins ». 5 champs : parcours de soin et organisation, douleur postopératoire, rétention d'urines, risque hémorragique, reprise du transit.

Méthodologie

Grille à 4 niveaux : **A** (preuve scientifique établie — essais randomisés de forte puissance, méta-analyses) ; **B** (présomption scientifique — essais randomisés de faible puissance, cohortes) ; **C** (faible niveau de preuve — cas-témoins, biais importants) ; **AE** (accord d'experts, en l'absence d'études). Sur les 43 recommandations, seules 3 énoncés portent un grade A explicite (limitation des perfusions IV, choix d'anesthésique local pour la rachianesthésie, analgésie multimodale) ; le reste relève de l'accord d'experts.

A

B

C

AE

Grille SNFCP — **A** : preuve scientifique établie ; **B** : présomption scientifique ; **C** : faible niveau de preuve ; **AE** : accord d'experts (absence d'études). Sur les 43 recommandations de ce document, seules 3 portent un grade A explicite — les grades B et C, bien que définis, ne sont utilisés pour aucune recommandation.

2.1 Parcours de soin et organisation (R1-24)

Réf.	Recommandation	Grade
R1	Privilégier le mode ambulatoire lorsque les conditions médicales et psycho-sociales d'éligibilité sont réunies.	AE
R2	Identifier le médecin traitant et les personnes ressources (accompagnant, aidant naturel, personne de confiance).	AE
R3	Vérifier les conditions d'ambulatoire à toutes les étapes ; délai pour atteindre une structure d'urgence ≤ 1 heure.	AE
R4	Une déficience physique ou intellectuelle n'interdit pas l'ambulatoire (nécessite des adaptations spécifiques).	AE
R5	Le grand âge n'interdit pas l'ambulatoire si les conditions d'éligibilité sont réunies (diminuerait le risque confusionnel).	AE
R6	La consultation de programmation opératoire est essentielle : chemin clinique, coordination des acteurs, information orale et écrite.	AE
R7	Organisation basée sur la gestion des flux (minimiser les pertes de temps, optimiser les circuits).	AE
R8	L'équipe de l'Unité de Chirurgie et Anesthésie Ambulatoire (UCA) doit être sensibilisée, expérimentée et formée.	AE
R9	Prise en charge au sein d'une unité d'accueil dédiée (réglementaire), recommandée à proximité immédiate du bloc opératoire.	AE
R10	Mettre en place une démarche de gestion des risques au sein de l'UCA.	AE
R11	Mettre en place une démarche qualité (taux d'échec, événements indésirables, EPP, RMM).	AE
R12	Le médecin anesthésiste doit être informé par l'opérateur du choix du mode ambulatoire et de la technique opératoire.	AE
R13	L'opérateur doit être informé en cas de réserve de l'anesthésiste sur le mode ambulatoire.	AE
R14	Prise en charge anesthésique définie par la RFE SFAR 2009 : jeûne préopératoire de 6 h (solides) et 2 h (liquides clairs sans pulpe ni gaz).	AE
R15a	Pour réduire l'incidence des rétentions d'urines, limiter les perfusions intraveineuses.	A
R15b	Si rachianesthésie choisie : anesthésique local de courte durée d'action, proscrire tout morphinique intrathécal.	A

Chirurgie ambulatoire en proctologie

Méthodologie, R1-43 (parcours, douleur, rétention, hémorragie, transit) & sources



Réf.	Recommandation	Grade
R15c	Prévenir dès la période opératoire la douleur postopératoire (antalgiques et techniques d'infiltration appropriées).	AE
R16	Informar le médecin traitant du caractère ambulatoire dès la consultation de programmation.	AE
R17	Le médecin traitant communique les informations utiles avant l'intervention et reçoit les éléments utiles après (compte-rendu, consignes, ordonnances).	AE
R18	Expliquer au patient les modalités et recueillir son assentiment ; informer de l'importance de respecter les consignes pré- et postopératoires.	AE
R19	La continuité des soins doit être organisée par l'UCA avec l'opérateur et l'anesthésiste, et formalisée par écrit.	AE
R20	Organiser par anticipation les mesures de sortie (ordonnances, consignes, rendez-vous postopératoire), réévaluées en postopératoire.	AE
R21	Délivrer au patient un dossier de liaison sur la nature du geste et les suites prévisibles.	AE
R22	Formaliser une procédure de contact (numéro de téléphone) pour la continuité des soins.	AE
R23	Vérifier la compréhension des consignes préopératoires par appel/SMS avant admission ; contacter le patient après le retour à domicile.	AE
R24	Informar le patient des signes évoquant une complication (rétention, hémorragie, douleur non contrôlée, fécalome) et de la conduite à tenir.	AE

2.2 Douleur postopératoire (R25-30)

Réf.	Recommandation	Grade
R25	Donner en préopératoire une information complète et détaillée sur la douleur postopératoire et sa prise en charge.	AE
R26	Évaluer systématiquement la douleur (échelle EVA/EVS/EN) et la prendre en charge rapidement ; n'autoriser le retour à domicile que si le score est faible.	AE
R27a	Privilégier l'analgésie multimodale, notamment par anesthésiques locaux de longue durée d'action (infiltration périnéale et/ou bloc pudendal).	A
R27b	Informar le patient sur l'effet et la levée du bloc pudendal — il n'est pas nécessaire d'attendre la levée du bloc pour autoriser la sortie.	AE
R28	Privilégier les analgésiques non opiacés (AINS, paracétamol) pour réduire la consommation d'opiacés et leurs effets secondaires.	AE
R29	Utiliser les opiacés en cas de contrôle incomplet de la douleur par les non-opiacés et l'analgésie régionale.	AE
R30	Fournir une ordonnance pré-établie dès la consultation ; s'assurer que le patient a anticipé l'achat des antalgiques disponibles à domicile.	AE

2.3 Rétention d'urines postopératoire (R31-38)

Réf.	Recommandation	Grade
R31	Informar le patient du risque élevé de rétention et l'évaluer systématiquement (âge, diabète, pathologie neurologique, obstacle uréthro-cervico-prostatique, type de chirurgie et d'anesthésie).	AE
R32	Obtenir une miction en préopératoire immédiat.	AE
R33	Limiter les médicaments augmentant le risque (morphiniques, anticholinergiques/néfopam) — tout en contrôlant la douleur, elle-même facteur de risque de rétention.	AE

Chirurgie ambulatoire en proctologie

Méthodologie, R1-43 (parcours, douleur, rétention, hémorragie, transit) & sources



Réf.	Recommandation	Grade
R34	Limiter les perfusions intraveineuses (cf. R15a — même recommandation, reformulée dans le contexte de la rétention urinaire).	A
R35	Chez un patient à faible risque : pas besoin d'attendre la reprise mictionnelle pour la sortie, sous réserve d'une évaluation du volume vésical.	AE
R36	Chez un patient à risque élevé : quantifier la miction et évaluer le résidu post-mictionnel (si possible par échographie) avant la sortie.	AE
R37	En cas de rétention, sondage évacuateur ou maintien d'un cathéter urétral (cf. RPC traitement de la maladie hémorroïdaire, SNFCP 2014).	AE
R38	Informar le patient de contacter la structure d'hospitalisation en l'absence de miction dans les 12 heures.	AE

Disclosure : R37 et R40 ne portent, dans le texte source, aucun marqueur de grade imprimé (ni « grade A/B/C » ni « AE ») — chippées AE ici par défaut, cohérent avec le reste du document qui ne connaît que ces deux issues (A explicite ou AE), non résolu silencieusement.

2.6 Risque hémorragique (R39-40)

Réf.	Recommandation	Grade
R39	La gestion du risque hémorragique doit être une préoccupation majeure de tous les intervenants ; informer patient et médecin traitant du risque précoce et tardif (jusqu'à 3 semaines), surtout après chirurgie hémorroïdaire ou résection de tumeur rectale.	AE
R40	Chez les patients sous antiplaquettaires/anticoagulants, discuter l'éligibilité à l'ambulatoire et le maintien/relais du traitement entre tous les intervenants (cardiologue, opérateur, anesthésiste).	AE

2.7 Reprise du transit (R41-43)

Réf.	Recommandation	Grade
R41	Prescrire en préopératoire des laxatifs et une alimentation enrichie en fibres pour améliorer le transit et diminuer la douleur aux premières selles.	AE
R42	Remettre avant l'intervention des conseils écrits en cas de constipation postopératoire.	AE
R43	Le patient doit contacter un référent médical en l'absence d'évacuation de selles dans les 72 heures.	AE

Sources et avertissement

SNFCP, avec l'ANAP et la SFAR, « Chirurgie ambulatoire en proctologie : texte des recommandations SNFCP », mars 2015. S'appuie sur un document produit par l'Association Française d'Urologie (Cuvelier et al., Progrès en Urologie 2013;23:62-66) et sur la RFE SFAR 2009 sur la prise en charge anesthésique en hospitalisation ambulatoire.

Avvertissement — document de 2015 : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 43 recommandations du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SNFCP/ANAP/SFAR. Les pratiques de chirurgie ambulatoire ayant pu évoluer depuis 2015, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.